林口長庚眼科部見習醫師注意事項

"The face is the mirror of the mind, and eyes without speaking confess the secrets of the heart."

—St. Jerome

各位學弟妹大家好，歡迎來到林長眼科實習！這裡不會有太多 critical 的病人，但由於專科屬性，會有較多與其他科不相同的地方，還要請大家仔細閱讀以下的注意事項；有任何問題，都歡迎詢問病房 NP，護理師、本 team 的學長姊，或是教學總醫師。認真負責的學弟妹們是很容易被注意到的，反之亦然；在眼科實習一般是不會太疲累，但還是希望大家能把臨床事務處理好喔！預祝各位在眼科實習的日子過的充實愉快 ☺

A. 聯絡方式：

1. 教學總醫師 (TCR)：(ophtcr@gmail.com) 王中鼎醫師 (GSM89395)
   a) 晨會負責: 吳柏毅醫師 (GSM89608)
   b) clerk 負責: 課程 –傅元楷醫師(GSM39016)、排班 –蔡宛蓁醫師(GSM15715)
2. 10J 眼科秘書：潘奕安 Tel: 8671
3. 各 Team 住院醫師與主治醫師：請參考「眼科工作分配表」及「次專科工作分配表」

B. Daily Activity

1. 白天行程：依照指導老師之行程，第一天報到前先聯絡給主治醫師，表達將會有一週的時間進行實習學習。有任何因教學活動需遲到、早退或不到者，應提前告知所跟之主治醫師以及住院醫師。
2. Orientation 將會提供 slit lamp DOPS 之表單，請學生進行學前評估，報到時候把表單給指導老師檢查，並同時跟老師討論本週學習目標。
3. 早上與 residents 共同進行 primary care 的病人之檢查與病歷書寫，詳情見下方 C5 Primary Care。
4. 眼科門診
   a) 早上 8:30 開始，下午 1:30 開始。
   b) 地點：林口兒童醫院 J 棟十樓門診區；台北九樓門診區。
5. 眼科開刀房
   a) 早上跟刀者，準時於 8:00 進開刀房；下午跟刀者，準時於 12:30 進開刀房。進刀房時請向主治醫師或住院醫師主動自我介紹。
   b) 林口刀房：兒童醫院 K 棟八樓眼科開刀房 [Room 71~79]。請由 9J 進入，尚未設卡請找學長姊幫忙刷卡進入，或是於早上八點半前於門口等。
   c) 9J 更衣室入口設卡：請至開刀房內供應室詢問設卡事宜 (Tel. 8131-843)
   d) 台北刀房：於提早至台北後棟九樓手術報到處詢問開刀房護理同仁。

C. 學術活動 (晨會表、實習醫學生值班表、眼科學見習課程表)

1. 晨會：時間與地點請參考「晨會表」。除了行政會議之外，全體醫學生不分專科，請務必準時 (07:30) 參加眼科部所有晨會。若為實體會議，請幫忙完成會議記錄。
2. 眼科部於各梯次將安排至少每周一次專屬晨會 [Clerk Teaching]，每位實習醫學生準備留守或值班時紀載之病歷內容，Residents or Chief Residents 將會現場提供 feedback 與教學。
3. 教學門診: 務必出席！時間詳見「實習醫學生值班表」。每週四早上或下午於台北 9F 教學門診，請事先聯絡上課醫師。教學門診請完成教學門診記錄表，並請主治醫師回饋與簽名。
   (**但葉龍坤醫師的教學門診無須提早聯絡，準時抵達門診即可)

4. 教學住診：共兩次。時間詳見電子郵件。請於教學住診前一天與負責主治醫師電話連絡確認時間地點（若需借 11J 討論室請與 11J 阿長借用）。教學住診後請完成教學住診記錄表（每週一張/人），整組需於住診記錄表封面頁簽名（每周一張/組），並請主治醫師回饋與簽名。
5. **Primary care:** 報到的第一天，請向當週指導老師的住院醫師聯絡，查詢被指派的 **primary care** 病人，每天早上負責跟 **resident** 一起檢查該病人、完成病歷，並準備發問/討論 **diagnosis and management** 的 **key points**。若當科剛好無住院病人，將由 CR 指派一個 **primary care**，不局限於當科病人。最終 **primary care** 的病歷需印出來，並「病歷記錄首頁」結業時交給秘書。**One primary care / 週，一週一個。**
6. 眼科學見習課程表: ☆ 請各組長於上課前 2-3 天與指導主治醫師聯繫確認時間地點；上課性質主要為 **tutorial**，請學生在上課前準備好國考二階該有針對 **topic** 的 **background knowledge**，鼓勵於上課時把握機會發問。
7. 可向 10J 眼科秘書借直接眼底鏡練習檢查，使用結束必須歸還。

D. 病房留守（Clerk-2 值班、AMWPM 留守表）病房事務會有專科護理師謝念恕 **supervise**，若有任何疑問，都可以發問並實作。

1. **OP Mark：由當日早上病房留守的人員於早上 8:00 準時至 8K 手術等候室為第一台 OPD 刀標示手術記號(眼角顳側畫箭頭指向眼睛)，並請待到 08:10 再離開。因換月或有其他原因無法完成者，請告之其他組員幫忙。**無故未出現者，一次扣總成績五分。
2. 幫忙從 10J 視力檢查室推 A / B-scan 至 8K 手術室報到櫃檯，請櫃檯人員聯絡該刀房．用畢再推回．（若不清楚，請參考 **orientation** 檔案提供之教學影片）
3. **New patient** 在 **supervision** 下開立 **admission order**．開立醫囑藥囑請通知該時段急診一線覆核，並協助完成留守當班 **new patient** 的 **admission note**。
4. 留守時間主動至病房詢問護理師是否有 **order** 需處理或藥物需稀釋：請看眼科 ORDER 本裡的待辦內容。
5. 可能會有病人血清需要製作泡藥，需協助至一樓抽血櫃檯「領取」血清交給 **np** 念恕泡藥。
6. 眼科藥物因屬性特殊，所以用藥頻次上會有不同，開法也有差異，幾個特殊的請注意：
   a) 可以開 **lgt** 的藥物（為有廠商生產的 **commercialized eyedrops**），請開 **lgt** + 頻次．除非是補藥量回來時才用 **1 pc ONCE**。藥膏為 **1qs.**
      ✧ 常見：**levofloxacin (cravit), prednisolone 1%, tropicamide, atropine 1%, BSS, betamethasone, chloramphenicol 0.25%, FML 0.1%**
   b) 無法開 **lgt** 的藥物（無廠商生產，多為需要泡製的 **antibiotics/antifungal/antiviral**），請選 **1 pc**，頻次選 **IRRE**，備註標明欲稀釋的藥物濃度與點藥頻率。
   c) 「IRRE」的使用時機：點藥頻次非系統既定頻次時（ex: 白天 Q1H、大夜 Q3H）、點藥時間有特殊需求時（BID, 但要在 08:30 and 23:30 兩個時間點藥）、開立的藥選 **1 pc** 而非 **lgt** 時（同 b）
   d) Night DC = night discontinue □ 大夜之後不點藥
   e) 請勿隨意開立"**STAT**"藥物，若有需要，開立後請立即告知主護，以利領藥作業。
   f) 眼科藥物（眼藥水和藥膏）一罐可以點好幾天，因此不需要每日回來一罐，每日量請寫 0．若有特殊用量再跟護理師確認．（如 **betamethasone**）

眼科藥物醫囑格式(例):				首日量	每日量	天數	備註
Amikin	*1PC*	***IRRE***	*OD*	*1*	***0***	*7*	*1gt 25mg/cc, Q1H, Night Q3H*
Pred forte	*1GT*	*Q1H*	*OU*	*1*	***0***	*7*	*Night DC*
Atropine 1%	*1GT*	***ONCE***	*OS*	*1*	***0***	***1***	補藥量
Phenylephrine 10%	*1GT*	***IRRE***	*OS*	*1*	***0***	*7*	*1gt cm 07:00 and stat on call to OR*

眼科 basic skills 教學重點：

Slit lamp examinations (配合 DOPS)

Cornea

The cornea is the transparent, anterior continuation of the sclera devoid of both blood and lymphatic vessels. The grey corneoscleral junction is called the limbus. A slit beam cross-section of a normal cornea reveals the following as shown in Figs 221, 222, and 223A:

1 anterior band: epithelium on Bowman's membrane;
2 cross-section: through stroma;
3 posterior band: endothelium on Descemet's

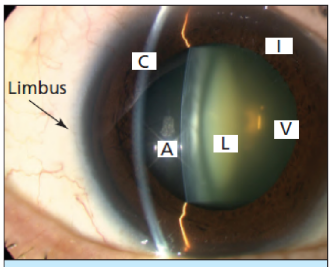


Fig. 221 Slit lamp view of anterior segment. C, cornea; A, anterior chamber; I, iris; L, lens; V, vitreous. Courtesy of Takashi Fujikado, MD.

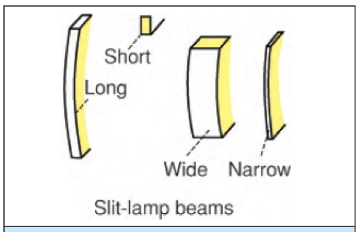


Fig. 220 Slit lamp beam.

The iridocorneal angle

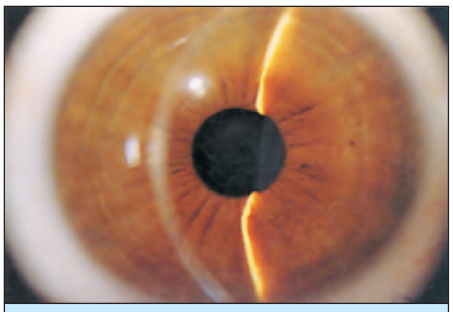


Fig. 306 Deep anterior chamber with wide open angle in long myopic eye.

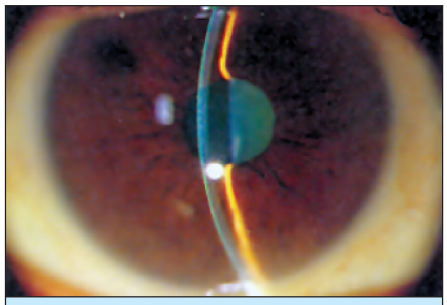


Fig. 305 Narrow angle in short hyperopic eye.

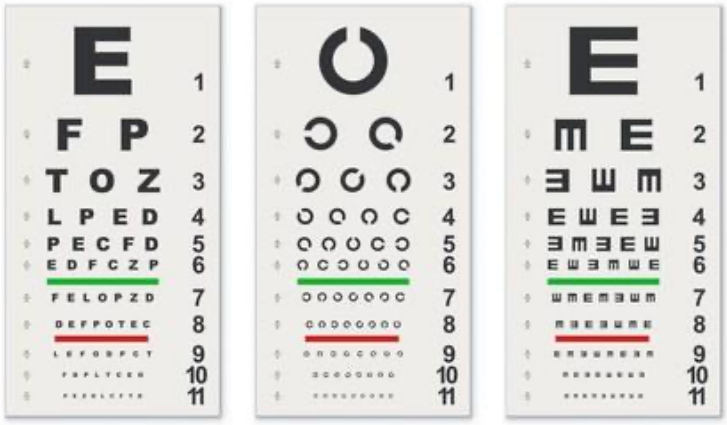
Measurement of Visual Acuity

1. There are three principal measures of VA:

• Unaided VA, often called uncorrected vision.
• Habitual ('presenting' or 'walk in') VA, with the patient's own glasses, if worn, or without glasses if not worn. (VAcPG)
• Optimal VA, with the best refractive correction BCVA (i.e., after subjective refraction).

Snellen VA is recorded as the smallest line in which the majority of the letters are seen and refined by appending plus or minus 1, 2, or 3 (e.g., 6/521, 20/2013). If the patient could not see the 6/60 letter at 6 m, but could at 2 m, record 2/60. Similarly if the patient could not see the 20/200 letter at 20 feet, but could see the 20/120 letter at5 feet, record 5/120.

Snellen (imperial)	Decimal[a]
20/10	2.0
20/12.5	1.60
20/16	1.25
20/20	1.00
20/25	0.80
20/32	0.63
20/40	0.50
20/50	0.40
20/63	0.32
20/80	0.25
20/100	0.20
20/125	0.16
20/160	0.125
20/200	0.10
20/400	0.05
20/800	0.025
20/2000	0.01



E. 值班 (Clerk-2 值班表)

1. 值班見習醫師須留守病房，處理病房事情。嚴禁擅離職守，代背手機，或屢 call 不回。不得任意換班，如有必要換班，須至眼科辦公室及 11J 病房登記。
2. 眼科病房以 11J 為主，兒童病人會住到 8L (皆由眼科負責)。
3. 平常日於早上 8:00、中午 12:30、下午 5:30 交班。值班至晚間十點.
4. 接完 new patient 或有病房處理問題請 call 值班 L1 cover，並確實完成 admission note。
5. 開立醫囑藥囑請通知當天 L1 覆核.
6. 晚間 9 點請主動至病房替隔天開刀病人作手術部位標記，可向護士拿隔天開刀病患名單，唱名與病患再次確認手術部位。標記部位為眼下方鼻樑側，畫記箭頭指向眼睛。
7. 請主動聯絡當天值班二線(L2)的 residents，一同看大床會診。

~眼科住院病患常見 complaint~

- ✓ 血壓高：可能是緊張或是疼痛導致。可先確認是否有足夠 pain control，以及是否有合併其他的 end organ damage，再決定是否需要較積極的處理 (可參考小麻中有關 hypertensive emergency 的處置建議)。
- ✓ 血糖高：若已經確診糖尿病並已經接受治療，住院中血糖過高建議直接注射 insulin 處理，並安排較為密切的血糖監控 (如一天測兩段或四段)，切記避免 over treat 造成低血糖。若尚未確診糖尿病，可以會診 meta 進行初步評估與藥物建議。
- ✓ Eye pain(刺痛) with tearing=> 可能是術後傷口痛，異物掉入眼睛，眼壓高，術後感染…，在給止痛藥之前必須 differential diagnosis。
- ✓ Eye pain(脹痛) with headache, nausea/vomit: 排除腸胃問題，可能是眼壓高，可試著幫病人量眼壓或請 call 住院醫師指導。
- ✓ 突然流大量眼淚 without pain：可能是 wound disruption 造成 aqueous leakage; 或是 corneal ulcer perforation。請 call 住院醫師指導。
- ✓ 治療用隱形眼鏡掉了 □ 請住院醫師重帶
- ✓ 請去了解病人狀況後自己 call 住院醫師，不要叫護士 call，並且跟隨住院醫師學習如何處理，可以在住院醫師 cover 下做簡單的 procedure.

F. 考核

1. 請於<u>實習月份結束前</u>上網填入評分住院醫師與主治醫師代號，以利線上評核登記。評分主治醫師請選擇會跟診或跟刀的醫師，住院醫師請選擇本 team 住院醫師。
2. 實習結束後，請於線上評分系統完成自評。
3. 紙本作業：
   a) 眼科部實習記錄表 xl：請把握跟診或急診留守機會，實際檢查病人後詳細記錄。
   b) 教學門診記錄表 xl：封面＋門診病歷（每人一份）．於教學門診時填寫。參加至少一次．
   c) 教學住診記錄表 x2：封面＋住院病歷（每人一份/每次住診）共參加兩次．（請將整組記錄表合併與封面頁一起裝訂）
   d) 「病例報告作業」與 primary care(包含 admission note and progress) x 2（一個禮拜一份）：「病例報告作業」需要記錄 Clerk Teaching 晨會中的討論，或是關於病人的 discussion，合同病歷（印出後請住院醫師批閱並簽名），完成後請當天直接交給秘書．
   e) 臨床教師回饋表 xl
   f) DOPS (Slit lamp) 評估表 x1

參考 schedule:

第一週	週一	週二	駐診教學	週四	週五	
Orientation Slit lamp教學 /DOPS	門診及手術室教學	台北門診教學	門診及手術室教學	臨床病理討論會 Case-based Discussion 葡萄炎之診斷與治療 Dr. 黃奕修3G 65854	門診及手術室教學	導師1
下午 1:00- 4:00	門診及手術室教學	門診及手術室教學	門診及手術室教學	門診及手術室教學	門診及手術室教學	
第二週	週一	週二	駐診教學	週四	週五	
上午 8:30- 11:30	臨床病理討論會 續發性青光眼 Dr. 莊蘭馨3G 60726	臨床病理討論會 黃斑部病變 Dr. 楊穎 3G 60727	臨床病理討論會 眼窩與眼皮疾病 Dr. 楊茹雯3G 60728	臨床病理討論會 陽形眼鏡常見的併發症 Dr. 孫啟欽3G 60723	門診及手術室教學	導師2
下午 1:00- 4:00	門診及手術室教學	門診及手術室教學	門診及手術室教學	門診及手術室教學	門診及手術室教學 交作業離開 /Feedback	

林口長庚眼科常見住院刀及醫囑

A. 一般原則:

1. 門診住院病人：請看最後一次的門診紀錄/開刀排程以及住院單，以查詢病人開刀術式及麻醉方法，請特別注意住院單備註欄，是否有手寫 special order，如: check KM + biometry
2. 急診住院病人：請看急診眼科會診病歷，裡面一般會有住院的醫囑，或是開刀 preop order。急診住院病人情況較多變，若有任何疑問，請務必與住院醫師確認。
3. **！！特別注意！！**：若是急診收刀，或是還沒有刀表排程的病人，**切勿提早開立 preop order**，否則會造成開刀無法計價！！
4. 局部麻醉:一般不需要抽血或做 CXR、EKG，除非住院單或開刀排程上有特別註明
5. 全身麻醉:必須要有術前三個月內的 CXR、Lab: (CBC, D/C, BUN/Cr, AST/ ALT, Na/ K)、40 歲以上需要 EKG
6. 全身麻醉之兒童
   I. 病患若無特殊病史，一般不需要抽血或 EKG 檢查
   II. 若不是第一台刀，一定要 on IV and fluid supplement
7. 一般開刀病患住院醫囑：

   >>Admission order

   >>Admitted to Dr._____'s service

   >>Vital Sign as ward routine (llJ 的 routine 是 QD)

   >>Diet: as tolerated/DM diet/low salt diet

   >>Activity:

   >>Allergy:

   >>Diagnosis:

   >>Pre-OP order: (若是急診收刀，或是還沒有刀表排程的病人，**切勿提早開立 preop order**，否則會造成開刀無法計價！！)

   >>OP Method:

   >>OP Site: (OD, OS, or OU)

   >>OP will be performed on (日期 under L/A or G/A) eg: 1050701 under

GA

>>Sign OP and anesthesia permit

>>NPO since ____ (一般是 MN, 全麻才要; 有 hypertension 可開 NPO 除 HTN 藥物外)

>>IVF (全麻才要; 但青光眼小樑切除術，角膜移植只需要 CM on lock，詳見後述)

>>Sent patient to OR on call with chart

>>Dilate pupil (視情況，某些刀才需要，詳見後述)

>>check finger sugar (DM 病患 NPO 後 Q6H check / DM 病患局麻手術當日：AC/PC check)

8. 藥囑：

I. 門診病患：參考眼科門診病歷開立（若有疑問請與住院醫師確認)

II. 急診病患：參考急診眼科會診病歷開立（若有疑問請與住院醫師確認)

III. 眼科之外病人的其他用藥，請務必與病人確認後完整開立

B. 特殊醫囑

白內障:

PEA+IOL: Phacoemulsification + IOL implantation	超音波晶體乳化術+人工晶體植入術
ECCE: Extracapsular cataract extraction	白內障囊外取出手術
- Dilate pupil (OD,OS,OU) with 1% Tropicamide + 10% phenylephrine (CM and stat on call to OR)	

視網膜剝離:

SB: Scleral buckling	鞏膜外扣術
TPPV/PPV: Trans-pars plana vitrectomy	經坦部玻璃體切除術
- Dilate pupil (OD,OS,OU) with 1% **Atropine**+ 10% phenylephrine (CM and stat on call to OR) – Sign 自費同意書: (TPPV 手術或是 TPPV+ scleral buckle): 重油 NT.15000, 矽油 NT.15000 (視病情使用)	

青光眼: (不需 dilate, 不需 IVF)

Trab.: Trabeculectomy	小樑切除術
+MMC	術中使用 Mitomycin C soaking
– CM on IV Lock 不要 IVF, except 全身麻醉之兒童 – Mannitol (20%) 300ml IVF stat on call before OP (於藥囑中開立並於附註註明, 若體重<40kg 或是兒童病患, 請與住院醫師確認劑量) – Mitomycin C 1PC stat TO OR (請 call 住院醫師開立) – 注意: 術前門診開的降眼壓藥要續用 (請開自備藥, 若門診降眼壓藥沒帶來不用開新的)	

角膜:

PK: Penetrating keratoplasty	全層眼角膜移植
– CM on IV Lock: 不要 IVF, except 全身麻醉之兒童 – Mannitol (20%) 300ml IVF once on call before OP (於藥囑中開立 ONCE 並於附註註明, 若體重<40kg 或是兒童病患, 請與住院醫師確認劑量)	

– Sign 自費同意書: 國內眼角膜及材料 NT.5000, 國外眼角膜及材料 NT.50000

Oculoplasty:

Orbital decompression	(甲狀腺凸眼症)眼窩減壓手術
Orbitotomy	眼窩腫瘤移除手術
- Transamine (500mg) 1PC once TO OR + Dexamethasone(5mg) 1amp once TO OR + Cefazoline (1gram) 1PC once TO OR	
Repair of orbital fracture	眼窩骨折修補手術
- Transamine (500mg) 1PC once TO OR + Dexamethasone(5mg) 1amp once TO OR + Cefazoline (1gram) 1PC once TO OR – Sign 自費同意書: Medpor 人工骨約 xxxx 元 (見排程或手術同意書)	
DCR: Dacryocystorhinostomy	淚囊鼻腔吻合術 (淚管阻塞手術)
– 不論是否註明內視鏡: 皆須開 = Transamine (500mg) 1PC once TO OR + Dexamethasone(5mg) 1amp once TO OR + Cefazoline (1gram) 1PC once TO OR **註明內視鏡** (Endoscopic/endonasal DCR): 需加開 = Oxymetazoline 0.05% nasal spray 1pc (1 spray CM and st on call to OR, then bring to OR) = Sign 自費同意書： 鼻腔止血棉約 4000 元	
Evisceration/Enucleation	眼球內容物剜除術/眼球摘除手術
Reconstruction of socket	眼窩重建手術
- Transamine (500mg) 1PC once TO OR + Dexamethasone(5mg) 1amp once TO OR + Cefazoline (1gram) 1PC once TO OR – Sign 自費同意書: 義眼球 (見排程或手術同意書註記之種類與金額)	

<u>其他手術</u>:

眼表層羊膜移植: AMG= amniotic membrane graft

斜視手術: R&R= recession and resection

眼瞼下垂: LR= levator muscle resection

睫毛倒插: Hotz operation 或 Snellen suture

小嬰兒全麻下檢查: EUA/EUG= Examination under general anesthesia

眼科常見縮寫 Common Ophthalmic Abbreviations

AC	Anterior Chamber	LI	Laser Iridotomy
APD	Afferent Pupillary Defect	NPDR	Non-Proliferative Diabetic Retinopathy
AMD	Age-related Macular Degeneration	NVD	Neovascularization of disc
CD	Cup-disc	NVG	Neovascular glaucoma
CF	Counting Finger	NVI	Neovascularization of iris (rubeosis)
CO	Cortical Opacity	OCT	Optical Coherence Tomography
DME	Diabetic Retinopathy	PACG	Primary Angle-closure Glaucoma
ET	Esotropia	POAG	Primary Open-angle Glaucoma
FAX	Fluid-air Exchange	PAS	Peripheral Anterior Synechiae
HM	Hand Motion	PI	Peripheral Iridectomy
HSV	Herpes Simplex Virus	PPA	Peripapillary Atrophy
HZO	Herpes Zoster Ophthalmicus	PRK	Photorefractive Keratectom
IVI	Intra-vitreal Injection	PVD	Posterior Vitreal Detachment
IOL	Intra-ocular Lens	PK,PKP	Penetrating Keratoplasty
K	Cornea	PH	Pinhole
Km	Keratometry	RD	Retinal Detachment
KP	Keratic Precipitate	RHT	Right Hypertropia
KSP	Superficial Punctate Keratitis	SB	Scleral Buckle
MH	Macular Hole	TBUT	Tear Break-up Time
MP	Macula Pucker	XT	Exotropia
NAION	Non-arteritic ischemic optic neuropathy	VAcC	Visual Acuity under Correction
NLP	No Light Perception	PSCO	Posterior Subcapsular Opacity
NS	Nuclear Sclerosis	PPV	Pars-plana Vitrectomy